

רפואה של פוטנציאל

גוף, אבחנה, טיפול ואדם שאינו מקרה

רפואה של פוטנציאל

גוף, אבחנה, טיפול ואדם שאינו מקרה

רפואה היא מבחן חריף לתאוריה מפני שהיא פוגשת את האדם במקום שבו הפוטנציאל שלו מצטמצם לכאב, סימפטום, תור, בדיקה, פרוטוקול וסיכון. הגוף אינו רעיון. הוא אינו מטאפורה. הוא המקום שבו האפשרות יכולה להיפתח, להיסגר, להישבר או להישאר תלויה. לכן רפואה של פוטנציאל אינה רפואה "רכה" מול רפואה מדעית; היא ניסיון לשמור את המדע בתוך יחס נכון אל אדם חי.

הכשל העמוק ברפואה אינו רק טעות אבחנתית או עומס מערכת. הכשל העמוק הוא החלפת החולה במקרה. כאשר אדם נעשה "כבד", "אונקולוגי", "פסיכיאטרי", "סיכון", "קוד אבחנה", משהו הכרחי קורה: המערכת צריכה לצמצם כדי לפעול. אבל משהו מסוכן גם קורה: הצמצום מתחיל להיראות כאמת כולה. רפואה צריכה קטגוריות, אבל אסור לה לשכוח שהקטגוריה היא ידית פעולה, לא האדם.

אפשר לנסח את הרפואה דרך מפת יחס: בריאות אחראית = גוף חי × אבחנה מדויקת × הקשבה × ראיות × זמן טיפול × המשכיות × הסכמה / עומס × דה־הומניזציה × פרוטוקול עיוור × פחד × מסחור × אוטומציה לא מפותחת. זו אינה נוסחה רפואית אלא מפת בלימה: היא בודקת מתי פרוטוקול מציל ומתי הוא מחליף שיפוט, מתי מדידה מאירה ומתי היא מסתירה אדם.

AI ברפואה הוא דוגמה מושלמת. מערכת יכולה לקרוא הדמיה, לסכם תיק, להציע אבחנה מبدלת, לזהות אינטראקציות תרופתיות, להתריע על סיכון או להקל עומס. אלה שימושים רבי ערך. אבל ברגע שהכלי מקבל הילה של ודאות, הוא עלול להפוך את הגוף לאוסף אותות ואת הרופא למאשר של מסקנה. הבעיה אינה עצם השימוש ב־בינה מלאכותית; הבעיה היא מחיקת אופק האחריות. כאשר המלצה אינה ניתנת להסבר, כאשר אין ברור מי אחראי, או כאשר הנתונים משקפים אוכלוסייה אחרת, הפוטנציאל הטיפולי הופך לסיכון.

הדוגמה הפשוטה היא כאב שאינו מופיע בבדיקה. רפואה גרועה אומרת: "אין ממצא ולכן אין בעיה." רפואה טובה אומרת: "אין ממצא בתוך אופק הבדיקה הנוכחי." ההבדל הזה הוא כל התאוריה: אמת יכולה להיות קיימת מעבר לכלי שיש כרגע. מצד שני, גם אסור להפוך כל תחושה לאבחנה. האופטימלי הרפואי נמצא בין שני כישלונות: ביטול האדם בשם המדידה, וביטול המדידה בשם האדם.

רפואה של פוטנציאל משתלבת עם אופקי גבול מפני שכל אבחנה היא אופק: מה אפשר לראות, מה עדיין נסתר, ומה מסוכן להסיק. היא משתלבת עם הקצה הרקורסיבי מפני שכל טיפול מוצלח פותח שאלה חדשה: שיקום, איכות חיים, מניעה, חיים עם מחלה, או שינוי מערכת. היא משתלבת עם AI מפני שהכלי יכול להיות פיגום מוסרי רק אם הוא מחזיר אחריות ולא גונב אותה.

הפרק אינו נותן ייעוץ רפואי. הוא מבהיר את תנאי האחריות: החולה אינו תוצר של בדיקה, הרופא אינו מתווך של אלגוריתם, והמערכת אינה רשאית לקרוא ליעילות "טיפול" אם היעילות נולדה ממחיקת הקשבה. רפואה של פוטנציאל היא המדע כשהוא זוכר עבור מי הוא מדויק.

משמעת מקורות

מקורות עבודה וזהירות: הפרק נשען על מסגרת התאוריה, ועל מקורות רקע כלליים שנבדקו מחוץ לפרומפט: UNESCO על בינה מלאכותית בחינוך, WHO על אתיקה וממשל של AI בבריאות, NIST AI RMF לניהול סיכונים CERN/ATLAS, AI על המודל הסטנדרטי וה- Higgs, NASA ו-ESA/Planck על קוסמולוגיה, Stanford Encyclopedia of Philosophy על Bell, Kochen-Specker וקונטקסטואליות, ו-Britannica/ISFDB לזיהוי ספרותי של Harlan Ellison ו- I Have No Mouth, and I Must Scream. המקורות אינם מוכנסים כהוכחות לתאוריה אלא כבלמים נגד שימוש ריק במונחים.